

Infarto Agudo do Miocárdio – Profilaxia Secundária

Vamos mergulhar agora na parte avançada das síndromes coronarianas, especificamente na **profilaxia secundária do infarto agudo do miocárdio**. Esse é um tema que aparece com frequência nas provas mais difíceis, então vale muito a pena dominar esse conteúdo.

Antes de começar, deixa eu te contar uma situação que ilustra perfeitamente o que vamos discutir. Imagina que você está naquele merecido descanso de fim de ano, Natal em família, aquela vibe boa. Aí chega na casa da avó e encontra o tio Jerônimo, 56 anos, tabagista de longa data. Ele te puxa de lado e conta que teve um infarto na semana passada, uma dor terrível, e que o médico do hospital passou uns remédios. Ele te entrega uma receita amassada com atenolol, aspirina, captopril, hidroclorotiazida, atorvastatina e bupropiona para cessar o tabagismo. E pergunta se está tudo certo, porque não quer passar por aquilo de novo.

Você olha a receita, dá aquela cara de entendedor, mas no fundo sabe que está faltando alguma coisa. Então resolve revisar suas anotações do KEDMA e descobrir o que está errado nessa prescrição. Ao final desta aula, você vai saber exatamente o que falta.

Mas antes disso, vamos para uma questão clássica. Questão da **PSU-MG 2024**, muito boa por sinal. Paciente avaliado no ambulatório **um ano após IAM**, sem queixas. Ele é portador de **diabetes mellitus tipo 2** e está em uso de AAS, clopidogrel, metoprolol, metformina 850mg duas vezes ao dia e atorvastatina 80mg por dia. No exame físico: PA de 110x70mmHg, frequência cardíaca de 72bpm. O ecocardiograma mostra hipocinesia de parede anterior, média e apical, com **fração de ejeção de 47%**. Nos exames laboratoriais: glicemia de jejum 145mg/dL, hemoglobina glicada de 8,7%, colesterol total 166mg/dL, HDL 34mg/dL, LDL 88mg/dL, creatinina 1,1mg/dL e potássio 4,5mEq/L. A questão pede para marcar a

alternativa **inadequada**. Atenção aqui, pegadinha clássica de prova: você precisa marcar o que está ERRADO, não o que está certo. Rabisca isso na prova para não se confundir.

Agora vamos ao que realmente importa: os **três pilares da profilaxia secundária de síndrome coronariana aguda**. Primeiramente, temos a **dupla antiagregação plaquetária**, depois a **terapia cardioprotetora** e, por fim, a **terapia para dislipidemia**. Vamos destrinchar cada um desses pontos.

Dupla Antiagregação Plaquetária

Esse é um dos temas mais discutidos na literatura cardiovascular atual. Para fins de prova, a regra de ouro é clara: **dupla antiagregação para todo mundo por pelo menos 12 meses**. Agora, se o paciente realizou cateterismo cardíaco com implante de stent, é preferível usar **ticagrelor ou prasugrel** ao invés do clopidogrel. Vale lembrar que isso não reflete totalmente a realidade do SUS, onde acabamos usando muito clopidogrel por questões de disponibilidade, mas em prova você sempre marca ticagrelor ou prasugrel quando o paciente tem stent.

Aqui começa a parte mais avançada, aquela que pode fazer você se destacar numa prova difícil. E se o paciente tiver **alto risco de sangramento**? Por exemplo, imagina um paciente que teve AVC hemorrágico prévio ou tem varizes esofágicas. Nesse caso, podemos fazer DAPT por apenas **um mês** e depois manter apenas com monoagregação. É uma evidência mais fraca na literatura, mas o raciocínio é lógico: o paciente precisa de alguma antiagregação, mas não podemos expô-lo demais ao risco de sangramento. O tempo exato é variável na literatura, mas a Sociedade Americana de Cardiologia atualmente usa esse período de um mês como referência. Pensa bem: são condições que não combinam, doenças que causam trombose versus doenças que causam sangramento.

Outro cenário complexo é o paciente que, além do IAM, tem **necessidade de anticoagulação**. O exemplo clássico é aquele que infartou e tem fibrilação atrial concomitante. Se esse paciente não tiver altíssimo risco de sangramento, você pode fazer **terapia tripla por uma a quatro semanas** - anticoagulante mais dois

antiagregantes. Isso é diferente da neurologia, onde no AVC a gente evita ao máximo essa combinação pelo risco hemorrágico cerebral. Mas aqui tem um detalhe importante: **a coronária não sangra facilmente**. O risco de sangramento coronariano é pequeno, mas o paciente pode sangrar em outros locais, por isso fazemos isso apenas por uma a quatro semanas com muito cuidado. Depois dessa janela inicial, você faz a transição para **anticoagulante mais um P2Y12** (ticagrelor, prasugrel ou clopidogrel) e mantém indefinidamente.

Essas recomendações vêm da **diretriz 2025 da American Heart Association**. Os últimos dois pontos que mencionei têm nível de evidência mais baixo, então o que você realmente precisa gravar é: para a grande maioria dos pacientes, vamos manter DAPT por no mínimo 12 meses, especialmente se o risco de sangramento for baixo.

Terapia Cardioprotetora

Aqui entram os heróis da cardiologia pós-infarto. Primeiro, **betabloqueador para absolutamente todo mundo**. Por quê? Porque ele diminui a remodelação cardíaca. Pensa comigo: o paciente teve um infarto, agora tem uma parede acinética no coração. O resto do músculo cardíaco vai ter que bater mais forte para compensar aquela área morta. Se você não usar betabloqueador, vai acontecer remodelação progressiva e o paciente vai evoluir para insuficiência cardíaca. O **metoprolol** é o que tem mais evidência científica. Essa evidência é ainda mais robusta em pacientes com fração de ejeção menor que 40%, mas usamos para todo mundo mesmo.

Segundo, **IECA também é para todo mundo**, pelo mesmo motivo: diminuir a remodelação cardíaca. De novo, a evidência é mais forte em pacientes com fração de ejeção abaixo de 40%, mas não restringimos o uso apenas a esse grupo.

Agora vem uma novidade importante: **iSGLT2 também é cardioprotetor** e diminui internações por eventos cardiovasculares. Então a tendência atual é utilizar em todo paciente que infartou. E tem mais: você pode usar iSGLT2 combinado com **agonista de GLP-1**, que também entra nesse grupo de medicações cardioprotetoras. Se o

paciente for obeso e já infartou, é preferível você utilizar um agonista de GLP-1. Pode usar os dois juntos sem problema algum, aliás.

Terapia para Dislipidemia

Aqui a regra é cristalina: **estatina de alta potência para todo mundo**. A meta clássica para esse paciente é LDL **menor que 50mg/dL**. Mas atenção para uma mudança de paradigma recente: a diretriz europeia de cardiologia e o Colégio Americano de Cardiologia em 2025 indicaram que esses pacientes podem se beneficiar de um LDL **menor que 40mg/dL**. Acho difícil isso cair em prova ainda, até porque nas aulas de diabetes mencionei que as diretrizes brasileiras usam 50 como ponto de corte, então é difícil as bancas já cobrarem o 40. Mas tenha isso em mente, essa possibilidade existe.

Quais são as estatinas de alta potência? **Atorvastatina 40 a 80mg** ou **rosuvastatina 20 a 40mg**. Se o paciente não chegar na meta mesmo com essas doses, você tem opções para adicionar: **ezetimiba 10mg** ou **inibidores de PCSK9** (alirocumabe ou evolocumabe). Essas últimas são medicações caríssimas, não disponíveis no SUS, mas funcionam muito bem.

E a Colchicina?

Você pode ter visto em algum lugar que existe evidência para colchicina. E realmente existe. O **estudo COLCOT** demonstrou que a colchicina em doses baixas pode reduzir o risco de novos eventos cardiovasculares. Então sim, você pode usar colchicina para o paciente.

Voltando à Questão

Agora vamos resolver aquela questão da PSU-MG. O paciente está um ano após o IAM, sem queixas, diabético tipo 2, usando AAS 100mg, clopidogrel 75mg, metoprolol, metformina e atorvastatina. É aquele paciente clássico do SUS, usando o que está disponível. São medicações boas, uma terapia bem otimizada. Poderia

ser melhor? Poderia. Ele poderia estar com iSGLT2, poderia estar com ticagrelor ao invés de clopidogrel, mas não tem problema. A terapia está boa.

No exame físico, PA 110x70mmHg, FC 72bpm. No ecocardiograma tem aquela hipocinesia que comentamos, ou seja, ele precisa mesmo de betabloqueador, está usando metoprolol corretamente para diminuir a remodelação. Fração de ejeção de 47%, glicemia de jejum 145mg/dL, hemoglobina glicada 8,7% (bem ruim), colesterol total 166mg/dL, HDL 34mg/dL, LDL 88mg/dL, creatinina 1,1mg/dL, potássio 4,5mEq/L.

Vamos analisar as alternativas de cima para baixo:

Letra A: Prescrever enalapril. É inadequado? Não! Esse paciente não está usando IECA nenhum. Ele está usando clopidogrel, metoprolol, metformina e atorvastatina, mas cadê o IECA? Esse paciente se beneficiaria muito de um IECA. "Ah, mas a pressão está 110x70, vai cair demais." Se ele se adaptar e conseguir ficar com enalapril, seria ótimo porque diminuiria o remodelamento. Então a letra A está **correta**, não é a inadequada.

Letra B: Prescrever ezetimiba. Olha o LDL desse paciente: 88mg/dL. Ele já está usando atorvastatina 80mg e não chegou na meta de 50mg/dL. Ele precisa de alguma medicação adicional. A ezetimiba seria uma ótima opção. Letra B **correta**.

Letra D: Suspender clopidogrel. Bom, já faz um ano, certo? Usamos dupla antiagregação por pelo menos um ano. Então você poderia sim suspender o clopidogrel nesse momento. Letra D **correta**.

Letra C: Substituir metformina por dapagliflozina. Aqui está o erro! Veja bem: o paciente está com hemoglobina glicada de 8,7%. Ele precisa de pelo menos **dupla terapia** para diabetes. Ele está usando apenas metformina. Você não vai **substituir** a metformina, você vai **adicionar** a dapagliflozina ou adicionar um agonista de GLP-1. Você vai somar medicações para esse paciente, de forma alguma trocar uma pela outra. Por isso a letra C está **inadequada** e é o gabarito.

Gatilho para Fixação

Grave esse gatilho mental para nunca mais esquecer a profilaxia secundária:

DAPT por 12 meses, de forma geral, com preferência para ticagrelor ou prasugrel se o paciente fez cateterismo.

Proteção para o miocárdio com betabloqueador, IECA e iSGLT2. Adicionando também agonista de GLP-1 se o paciente for obeso.

Estatina de alta potência para todo mundo e colchicina pode ajudar também.

Esse é o resumo da profilaxia secundária. É uma aula mais complexa, muita coisa aqui ainda nem caiu em prova, mas quando aparecer vai ser aquela questão difícil que separa quem estudou bem de quem estudou mais ou menos. Por isso colocamos na aula avançada. Domine esse conteúdo e você vai se destacar na hora da prova.